三、消化性溃疡的检查

穿孔不能用

1.**胃镜**（首选、金标准）：诊断**消化性溃疡及并发出血/幽门梗阻/癌变、残胃癌**

胃镜本身扩张幽门 ↓ 胃大部切除术并发症

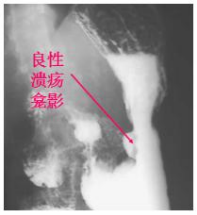
2.钡餐

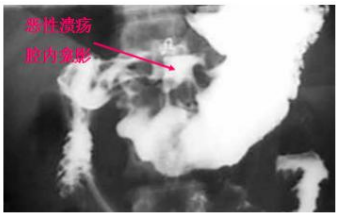
VS胃癌:龛影在胃腔轮廓内 溃疡底部瘢痕收缩

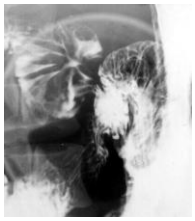
①诊断消化性溃疡次选：壁外龛影、粘膜纠集、三叶草样恒定畸形（十二指肠球部溃疡）

钡剂漏出去 瘢痕收缩

②**禁用**：消化道穿孔、完全性梗阻 钡剂排不走







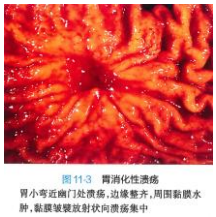
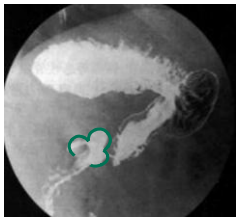


图 11-3 胃消化性溃疡
胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞放射状向溃疡集中



四、消化性溃疡的并发症

消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血

（一）出血（最常见）

1.上消化道出血最常见的原因是**消化性溃疡**（40-50%）；上消化道出血次常见的原因是门脉高压食管胃底曲张静脉破裂（20-25%）

2.出血好发部位：GU-胃小弯，DU-球部后壁。出血以 DU 多见 壁更薄

3.临床表现

咖啡样:混有胃液 VS 食管贲门粘膜撕裂综合征:剧烈呕吐后呕出鲜血(位置高)

肝硬化、门脉高压、食管胃底静脉曲张破裂出血呕出鲜血(位置高)

①部分患者以上消化道出血作为首发症状，部分患者的腹痛在出血后可减轻 血液稀释胃酸,刺激↓

②呕血（多为**咖啡样**血液）、**黑便**

③上消化道出血表现为呕血或便血及颜色取决于：出血的**速度**（主要）、**量**（主要）、**部位**（速度测量部位）

黑便:红细胞内的铁和硫化氢生成硫化亚铁 已定位在上消化道

《诊断学》：出血量 **5**ml 仅粪**隐血**试验阳性、**50**ml 可有**黑便**、**250**ml 可有**呕血**，＞400ml 可有头晕/心悸/乏力等症状，**＞800-1000ml 可休克**（五五二百五是吧一休哥）XXX减轻了不一定是好事

④**肠鸣音↑**

①典型的哮喘是弥漫响亮的哮鸣音,危重症哮喘减弱甚至消失

②胸膜摩擦音/心包摩擦音随积液量↑,脏壁两层分开就听不见

③结节病一期双肺门淋巴结肿大,二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影

三期肺门淋巴结肿大消失,只有肺部浸润影

④肾自截

《诊断学》：肠鸣音正常 4-5 次/分

肠鸣音↑ 里面刺激肠子	**消化道出血、肠道炎症和结核、机械性肠梗阻**（亢进呈金属音调）、痉挛性肠梗阻（如急性肠炎、铅中毒）
肠鸣音↓ 外面抑制肠子	**麻痹性肠梗阻（腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药、中毒性巨结肠等）**

阻断肠道M-R

平滑肌无力

溃疡性结肠炎并发症

低钾血症时心肌兴奋性先↑后↓(按通透性分析)

血钾↓,细胞膜对钾的通透性↓,钾外流减少,静息电位↓靠近阈电位,兴奋性↑

静息电位离阈电位过近则兴奋性↓

4.提示消化道**活动性出血** 一直出血

①**反复**呕血、或黑便/血便**次数增多**，**肠鸣音活跃**

②周围循环状态经充分补液及输血后未见明显改善，或虽暂时好转而又恶化

③血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容**继续**下降

需排除肾脏自身问题

④补液与尿量足够的情况下、**血尿素氮持续或再次升高**

⑤**胃管抽出物有较多新鲜血** 肠源性氮质血症(肠子重吸收血红蛋白)

注意：由于肠道内积血需经约 3 天才能排尽，因此**黑便不提示继续出血**

小凯笔记补充

干扰选项:

①肠鸣音减弱❌

②黑便❌

③漏选血尿素氮持续/再次升高